SENA E BITTAR

CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA EMPRESARIAL

Cesta de produtos
três etapas, três faixas

Sugestão para análise dos sócios

A ideia

Hoje vocês têm um produto só, de 90 dias. O cliente paga, recebe, e vai embora. Quem for comprar de novo tem que ser convencido de novo, do zero.

A proposta tem dois movimentos. O primeiro é partir o trabalho em três etapas que se vendem uma à outra, fechando doze meses. O segundo é reconhecer que uma clínica de quatro salas e uma rede de oito unidades não compram a mesma coisa, e separar a cesta em três faixas de cliente.

	ETAPA	MESES	O QUE ACONTECE
1	Mentoria Business Medical	1 a 3	Descobre onde o dinheiro se perde e decide o que mudar
2	Implantação	4 a 6	Tira a decisão do papel e bota pra rodar
3	Acompanhamento	7 a 12	Mantém de pé, mede e fecha o ano fiscal

A lógica que amarra as três: decidir, aplicar, sustentar. São três trabalhos diferentes, e é desonesto cobrar os três como se fosse um só.

Cada etapa tem entrega própria, preço próprio e porta de saída própria. O cliente pode parar em qualquer uma, e é justamente isso que faz ele continuar.

As três faixas de cliente

A esteira é a mesma nas três. O que muda é a profundidade do diagnóstico, quem senta na mesa e quantas unidades entram na conta.

FAIXA	PERFIL	FATURAMENTO TÍPICO	QUEM SENTA NA MESA
A Clínica	1 unidade, 1 CNPJ, de 1 a 4 salas ou cadeiras. O dono é o profissional	R$ 200 a 600 mil por mês	O dono, e às vezes a sócia ou a gerente
B Hospital dia	Centro cirúrgico ambulatorial, internação de curta permanência, corpo clínico próprio, convênios	R$ 600 mil a R$ 2,5 milhões por mês	Dono, administrador e coordenação de enfermagem
C Rede e grandes hospitais	Várias unidades, vários CNPJs, diretoria formada	acima de R$ 2,5 milhões por mês	Sócios, diretoria e o financeiro

O que muda em cada faixa

Faixa A, clínica. É o desenho que já está pronto. Diagnóstico de uma unidade com a ficha de anamnese atual, painel único dos quatro indicadores, encontros on-line com presencial na abertura e no fechamento. O interlocutor é o dono, e tudo que for decidido depende dele para acontecer.

Faixa B, hospital dia. O diagnóstico ganha quatro frentes que não existem na clínica: custo por procedimento com sala, equipe e material; convênios e glosa; escala e ocupação de sala; e os contratos do corpo clínico. O painel deixa de ser único e passa a ser por centro de custo. Pelo menos um encontro presencial por trimestre, porque parte do diagnóstico se faz andando dentro da operação.

Na conta tributária, a redução de 60% de IBS e CBS alcança serviço hospitalar e ambulatorial, pelos arts. 128 a 134 da LC 214/2025. O ponto de atenção é a classificação na NBS: código errado perde o redutor mesmo sendo saúde de fato. Está fichado em `conhecimento/reforma-tributaria-saude-geral.md` .

Faixa C, rede e grandes hospitais. Aqui o trabalho muda de natureza. O diagnóstico é por unidade e consolidado, com as unidades comparadas entre si. A entrega deixa de ser rotina e passa a ser política: o padrão precisa ser replicável em oito lugares, não combinado com oito gerentes.

Duas coisas que o Gilberto já aprendeu em rede multiunidade e que entram como condição, não como sugestão:

- **Centro de custo separado por unidade.** Sem isso, a unidade que fatura tapa o buraco da que não performa, a dívida real nunca aparece e o diagnóstico inteiro fica mentiroso.
- **Acesso à informação na fonte e mandato formal.** Procuração digital para ver o fiscal direto, e o compromisso escrito de quem manda sobre não atravessar a execução. Sem os dois, o SB não entra.

Está em `conhecimento/turnaround-rede-multiunidades-diagnostico-gargalos.md` , que é caso real.

Etapa 1. Mentoria Business Medical

Meses 1 a 3. Já existe, já está desenhada e já tem preço na faixa A. Está inteira em `plano-de-mentoria.md` .

O que o cliente leva embora: a linha de base dos quatro indicadores, o mapa de classificação dos serviços dele na reforma, o regime tributário decidido, a tabela de preço revista e um plano de ação nos quatro pilares.

Na faixa B, soma o custo por procedimento e o mapa de convênio e glosa. **Na faixa C**, soma o diagnóstico por unidade, o consolidado e a leitura de governança: quem decide o quê, e o que hoje não tem dono.

Como esta etapa vende a seguinte

Na reunião de fechamento do dia 90, com o plano de ação aberto na mesa. A pergunta que abre a venda: *a decisão está tomada. Quem vai estar junto quando ela for aplicada?*

É a hora de maior prova e de menor resistência, porque o cliente acabou de ver o diagnóstico virar número.

Etapa 2. Implantação

Meses 4 a 6. Três meses para tirar do papel o que foi decidido.

Esta é a etapa que hoje não existe, e é onde a maioria das consultorias perde o cliente. Entre a decisão tomada e a decisão aplicada mora um trimestre inteiro, e é nele que se descobre o que de fato pegou.

MÊS	PILAR	CONDUZ	O QUE FICA DE PÉ
4	01 Gestão	**Sena**	Rotina de fechamento mensal rodando sem o dono, contas separadas de verdade, regime tributário aplicado na prática, folha organizada
5	02 Marketing e 03 Vendas	**Bittar**	Origem de paciente rastreada no sistema, caminho da primeira mensagem à consulta em operação, roteiro de orçamento treinado com a equipe, recall e indicação rodando
6	04 Lucratividade	**Sena**	Tabela de preço aplicada, margem medida por procedimento com dado real, mix e convênios revistos, ponto de equilíbrio coberto

Formato

ITEM	CADÊNCIA
Encontro de 1h30 com o sócio do pilar do mês	1 por mês, 3 na etapa
Painel dos quatro indicadores, fechado e comentado	todo mês
POP das rotinas críticas, escrito e entregue	ao longo dos 3 meses
Fechamento com os dois sócios	no mês 6, contra a linha de base
Canal direto	aberto

Por que o POP entra aqui e não na mentoria. Procedimento escrito antes da decisão documenta o erro. Depois da decisão, documenta o acerto, e é o que permite a clínica continuar rodando quando a pessoa que fazia aquilo sai de férias ou pede demissão.

Na faixa B, a implantação passa pela escala e pela sala: o POP vira rotina de centro cirúrgico e de faturamento de convênio. **Na faixa C**, implanta-se numa unidade-piloto primeiro e só depois replica nas outras, com o padrão escrito antes de sair da primeira.

Como esta etapa vende a seguinte

No fechamento do mês 6, com o painel mostrando o primeiro indicador que virou. A frase: *o difícil foi fazer subir. Agora é não deixar descer.*

Etapa 3. Acompanhamento

Meses 7 a 12. Seis meses de manutenção e medição, fechando o ano.

ITEM	CADÊNCIA
Encontro de 90 min com o dono do pilar da vez	1 por mês, rodízio Sena e Bittar
Encontro com os dois juntos	1 por trimestre, 2 na etapa, um deles presencial
Painel dos quatro indicadores, fechado e comentado	todo mês
Canal direto para dúvida pontual	aberto
Fechamento fiscal do ano	no mês 12
Diagnóstico refeito e comparado	no mês 12, contra a linha de base do mês 1

As duas entregas do mês 12 são o coração desta etapa. A conta de imposto se decide no calendário, não no semestre, e com a reforma entrando é a entrega que mais vale no público de vocês. O diagnóstico refeito é o que renova o contrato sem vocês precisarem vender de novo: o cliente vê, em número, o que doze meses fizeram com a empresa dele.

Renovação automática por mais 6 meses, salvo aviso de qualquer das partes com 30 dias. É esta linha que transforma mentoria em receita recorrente.

Na faixa C, é aqui que entra o conselho consultivo que vocês já desenharam, de R$ 360.000 ao ano em 4 parcelas trimestrais. Aquilo nunca foi o degrau seguinte da clínica: é o produto desta faixa, e o acompanhamento é a porta de entrada dele.

Os valores, separados por etapa e por faixa

Todos à vista, no pix ou cartão.

ETAPA	A · CLÍNICA	B · HOSPITAL DIA	C · REDE E GRANDES HOSPITAIS
1 Mentoria, meses 1 a 3	R$ 50.000	R$ 90.000	R$ 180.000
2 Implantação, meses 4 a 6	R$ 30.000	R$ 60.000	R$ 120.000
3 Acompanhamento, meses 7 a 12	R$ 40.000	R$ 80.000	R$ 160.000
O ano, etapa por etapa	**R$ 120.000**	**R$ 230.000**	**R$ 460.000**

Parcelado, etapa por etapa

ETAPA	A · CLÍNICA	B · HOSPITAL DIA	C · REDE E GRANDES HOSPITAIS
1 Mentoria	12x de R$ 5.000	12x de R$ 9.000	12x de R$ 18.000
2 Implantação	6x de R$ 5.500	6x de R$ 11.000	6x de R$ 22.000
3 Acompanhamento	6x de R$ 7.500	6x de R$ 15.000	6x de R$ 30.000

O ano fechado de uma vez

FAIXA	À VISTA	PARCELADO	ECONOMIA SOBRE A SOMA DAS ETAPAS
A Clínica	**R$ 105.000**	12x de R$ 10.000	R$ 15.000
B Hospital dia	**R$ 200.000**	12x de R$ 19.000	R$ 30.000
C Rede e grandes hospitais	**R$ 400.000**	12x de R$ 38.000	R$ 60.000

Em todas as faixas vale a mesma leitura, e ela fecha venda sozinha: **quem fecha o ano e parcela em doze paga mais ou menos o que pagaria comprando cada etapa à vista, uma de cada vez.** O parcelamento do ano sai de graça.

A régua de quem aguenta pagar

FAIXA	CUSTO NO ANO	SOBRE O FATURAMENTO ANUAL
A Clínica de R$ 400 mil por mês	R$ 120.000	2,5%
B Hospital dia de R$ 1,2 milhão por mês	R$ 230.000	1,6%
C Rede de R$ 4 milhões por mês	R$ 460.000	1,0%

Quanto maior o cliente, maior o valor absoluto e menor o percentual. É assim que funciona em honorário de gestão, e é o argumento que desarma a objeção de preço no cliente grande: proporcionalmente, ele paga menos que a clínica.

Abaixo de R$ 200 mil por mês, a esteira inteira não cabe. Nesse caso vendam só a mentoria, e não empurrem etapa que o cliente não sustenta.

A conta de vocês

Um cliente de clínica que percorre a esteira inteira vale R$ 120.000 em vez de R$ 50.000. São 2,4 vezes o mesmo cliente, sem prospectar ninguém novo.

CENÁRIO, SOBRE 10 CLÍNICAS DE MENTORIA	RECEITA NO ANO
Hoje: todos param no dia 90	R$ 500.000
6 vão para a etapa 2, 3 chegam na etapa 3	R$ 800.000
8 vão para a etapa 2, 5 chegam na etapa 3	R$ 940.000

E a faixa muda a escala do negócio inteiro. **Um hospital dia que fecha o ano vale o mesmo que quatro clínicas e meia de mentoria.** Uma rede vale nove.

UM CLIENTE DE CADA FAIXA, ANO FECHADO	RECEITA
Clínica	R$ 120.000
Hospital dia	R$ 230.000
Rede ou grande hospital	R$ 460.000
Os três juntos	**R$ 810.000**

Três clientes no ano, um de cada faixa, pagam a operação dos dois sócios.

Minha opinião, e três alertas

Vendam etapa por etapa, não o ano. O pacote fechado é bonito na planilha e perigoso na prática: quem compra doze meses no primeiro dia é exatamente o cliente que some no mês sete, e aí vocês carregam a obrigação de entregar para alguém que já desistiu. Deixem o pacote guardado para quem pedir.

A etapa 2 é a que sustenta o negócio. É ela que transforma a mentoria em esteira. Sem ela, a etapa 3 fica longe demais do dia 90 e a maioria não chega lá.

A faixa C é outra venda, não um cliente maior. Tem processo de compra, leva meses, passa por mais de uma cabeça e muitas vezes começa em crise, não em crescimento. Não dá para prospectar faixa C com o mesmo material da faixa A, e é melhor entrar nela por indicação do que por anúncio.

Comecem por B. A faixa A paga a conta do mês e a faixa C constrói o nome, mas é o hospital dia que tem dor de gestão de verdade, dinheiro para pagar e decisão concentrada em pouca gente. É a faixa mais fácil de fechar para o tamanho que vocês têm hoje.

O que precisa da palavra de vocês

1. As três faixas fazem sentido, ou o corte é outro?
2. Os nove preços da matriz ficam de pé?
3. O pacote do ano existe, ou cortamos para proteger a venda etapa por etapa?
4. Os nomes. "Implantação" e "Acompanhamento" são sugestão minha.
5. A renovação automática da etapa 3 entra em contrato?
6. A faixa B e a faixa C precisam de ficha de diagnóstico própria. A atual foi escrita para consultório. Se quiserem, eu monto as duas.
